

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE MIT LEBEN WERDEN KAMPFEN
Kennzeichen/ Fundstelle	Bezeichnung des Dokumentes: Verfahrensanleitung Herzbettlagerung	

Definition:

Verschiedene Krankheitsbilder erfordern es, ein geschwächtes Herz zu entlasten. Wir nutzen dafür die Herzbettlagerung, da in dieser Liegeposition das zirkulierende Blutvolumen reduziert wird.

- Kernelement der Herzbettlagerung ist die tiefe Lagerung des Beckens und der Beine sowie die erhöhte Positionierung des Oberkörpers. Ein Teil der Blutmenge bleibt so in den Beinen. Durch die Verstellung des dreigeteilten Lattenrostes entsteht der typische "Doppelknick", der verhindert, dass der Bewohner in Richtung Bettende rutscht.
- Aus diesem Grund heißt die Herzbettlagerung auch "Kopf-hoch-Bein-tief-Lagerung" oder "Cardiac-Chair-Lagerung".
- Die Herzbettlagerung ist nicht mit allen Pflegebetten möglich. Notwendig sind sog. "Herzbetten" mit einem nach unten verstellbaren Fußende.
- Bei vielen Betroffenen zeigt die Herzbettlagerung eine beruhigende Wirkung. Der Körper des Bewohners wird in dieser Position gestützt und kann sich entspannen. Gleichzeitig hat der Bewohner aufgrund des erhöhten Oberkörpers einen guten Überblick über alle Aktivitäten in seiner Umgebung.
- Die Herzbettlagerung eignet sich auch für eine anfängliche Mobilisierung. Viele Betroffene verbrachten die Monate zuvor flach liegend im Bett. Nun wird der Aktionsradius deutlich erweitert. Die Bewohner können nun z. B. leichter telefonieren, fernsehen, essen oder lesen.

Grundsätze:

Die individuellen Wünsche des Patienten sind uns wichtig und werden beachtet.

- In der Sterbephase hat bei der Wahl der Lagerung die Bequemlichkeit Priorität.
- Das Lagern ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die viel berufliche Erfahrung erfordert. Daher werden Praktikanten und Pflegeschüler nur assistierend eingesetzt.
- Uns ist bewusst, dass bei einem erhöht gelagerten Oberkörper das Risiko von Kontrakturen oder von Druckgeschwüren messbar steigt. Dieses ist jedoch kein

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	1	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM KLINIKUM KÖLN
Kennzeichen/ Fundstelle	Bezeichnung des Dokumentes: Verfahrensanleitung Herzbettlagerung	

hinreichender Grund, um auf die vielen Vorteile dieser Lagerung zu verzichten. Allenfalls wird die Sitzposition zeitlich eingeschränkt.

Ziele:

- Patient empfindet diese Lagerung als angenehm
- Die Atmung wird erleichtert
- Wir entlasten das Herz
- Komplikationen wie Dekubitus, Thrombosen, Pneumonien und Kontrakturen werden vermieden
- Der Bewohner nutzt den erweiterten Bewegungsspielraum, um mehr Tätigkeiten eigenständig durchzuführen und die Abhängigkeit von den Pflegekräften zu reduzieren

Vorbereitung:

Material :

- zwei dünnere Kissen
- eine dünne Bettdecke
- zwei dicke Kissen

Durchführung:

im Pflegebett:

Das Kopfteil des Betts wird aufgerichtet. Ideal ist ein Winkel, wie er auch beim Eingeben von Speisen üblich ist. Wir achten darauf, dass der Knick des Hüftgelenks präzise mit dem Knick des Betts übereinstimmt. Der Knick darf nicht zu hoch und nicht zu tief angesetzt werden. Ggf. korrigieren wir die Position des Patienten

- Die Pflegekraft legt ein Kissen unter den Kopf und unter die Schultern. Wir achten darauf, dass das Kissen möglichst faltenfrei ist.
- Beide Unterarme werden bei Bedarf mit je einem Kissen unterlagert, die ggf. zuvor in Schiffchenform gefaltet wurden. Damit ist sichergestellt, dass der Schultergürtel entlastet wird. Die Position ist für den Patienten dann deutlich angenehmer. Die Kissen sollten den Patienten nicht einengen. Diese Position mit unterlagerten Armen ist auch als "Paschasitz" bekannt.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	2	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE an der Uniklinik Köln
Kennzeichen/ Fundstelle	Bezeichnung des Dokumentes: Verfahrensanweisung Herzbettlagerung	

- Das Fußende des Betts wird nun abgesenkt. Auch hier liegt der Knick des Fußendes über dem Kniegelenk des Bewohners.



Viele Betten bieten auch die Möglichkeit, den gesamten Rahmen samt Liegefläche in Richtung des Fußendes abzusenken. Bei diesen Betten wird zunächst das Kopfteil hochgefahren und dann das Fußteil etwa angehoben. Um die Füße letztlich wieder unter dem Höhenniveau des Beckens zu positionieren, wird nun das ganze Bett in Richtung des Fußendes gekippt.

- Die Pflegekraft fragt den Patienten, ob die Position angenehm ist. Sie achtet vor allem auf die Rumpf- und auf die Kopfstabilität. Ggf. muss das Kopfende wieder etwas abgesenkt werden.
- Wenn es der Patient wünscht, öffnen wir das Fenster. Frische Luft erleichtert das Atmen.
- Falls nötig decken wir den Patient zu. Viele Betroffene verzichten lieber auf eine Decke, da diese sie einengt und die Atmung erschwert. In diesem Fall passen wir die Kleidung und die Raumtemperatur entsprechend an.
- Wir legen ein dickes Kissen zwischen die Fußsohlen und das Brett am Bettende. Alternativ kann eine gefaltete Wolldecke oder ein gepolsterter Lagerungsblock genutzt werden. Ggf. unterpolstern wir die Unterschenkel, damit die Fersen frei liegen.

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	3	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE FÜR LEBEN UND SCHUTZ
Kennzeichen/ Fundstelle	Bezeichnung des Dokumentes: Verfahrensanleitung Herzbettlagerung	

Durchführung mit Sessel

- Steht kein geeignetes Pflegebett zur Verfügung, kann alternativ ein Sessel genutzt werden. Ideal sind sog. "Schlafsessel", deren Rückenlehne sich nach hinten zurück klappen lässt. Oft fährt dann auch eine zusätzliche Fußstütze hoch.
- Die Pflegekraft hilft dem Bewohner, sich in den Sessel zu setzen.
- Die Unterarme werden mit Kissen oder mit gefalteten Decken unterlagert.

Nachbereitung:

Wenn der Bewohner in die Herzbettlagerung gebracht wurde, sollte die für Herzschwäche typische Symptomatik nachlassen. Wir prüfen, ob dieses wirklich der Fall ist. Zudem überwachen wir die Vitalwerte engmaschig.

- Die Herzbettlagerung erleichtert zwar die Atmung sowie die Herztätigkeit, allerdings kann diese Positionierung auch zu einem Abfall des arteriellen Blutdrucks führen. Wir achten auf Anzeichen für einen kardiogenen Schock oder für eine Minderdurchblutung des Gehirns. Typisch sind etwa Schwindel oder Bewusstseinsstörungen. Je nach Schwere der Symptome wird die Lagerung etwas flacher gewählt oder abgebrochen.
- Ein Betttisch wird in Reichweite des Patienten geschoben, damit sich der Pflegebedürftige mit etwas beschäftigen kann. Es kann nun auch der Fernseher u. Ä. angestellt werden.
- Wir führen jetzt eine ggf. vorgesehene Inhalation durch.
- Die Herzbettlagerung muss regelmäßig unterbrochen werden, um den Patienten umzulagern. Vor allem am Steiß können durch die Rückenlage Druckverhältnisse auftreten, die die Ausbildung eines Dekubitus fördern. Das Lagerungsintervall ist individuell höchst unterschiedlich und wird nach Abwägung aller Risiken festgelegt. Dazu zählt auch die Entwicklung von Thrombosen, Pneumonien und Kontrakturen. Entsprechende prophylaktische Maßnahmen integrieren wir in die Pflegeplanung.

Dokumente:

- Berichtsblatt
- Lagerungs- und Bewegungsplan
- Pflege- und Maßnahmenplanung

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	4	Verw./MA

Egbert Schindler	Qualitätsmanagement Handbuch	 SCHINDLER INTENSIVPFLEGE AM LEBEN WIRTSCHAFTS
Kennzeichen/ Fundstelle	Bezeichnung des Dokumentes: Verfahrensanweisung Herzbettlagerung	

Freigabe	Bearbeiter	Datum	Änderung	Version	Seite	Verteiler
GF	PDL/QMB	01.01.2024		001	5	Verw./MA